



首頁



預防接種



疫苗簡介



公費疫苗



白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗
(DTaP-Hib-IPV)



白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 (DTaP-Hib-IPV)



◎疾病簡介

- **白喉**：是由白喉棒狀桿菌所引起的急性呼吸道傳染病，主要侵犯扁桃腺、咽頭、喉頭、鼻腔，被侵犯的部位因組織壞死，病灶處形成灰白色膜，四周伴有發炎現象。我國自民國70年以後已無白喉確定病例。
- **破傷風**：是由破傷風桿菌所引起的疾病，通常發生在低度開發或農業區，主要因為當地病患與動物排泄物接觸機會高，或預防接種不完全，且老年人及嬰幼兒死亡率較高。破傷風桿菌感染僅侷限於壞死組織，不會導致組織破壞或發炎反應，但破傷風桿菌產生的神經性外毒素，會影響中樞神經系統及自主神經系統，導致嚴重的神經性症狀與死亡。
- **百日咳**：是由百日咳桿菌所引起的疾病。百日咳一年四季都可能發生，病患多半是5歲以下兒童，嚴重症狀好發在6個月以下嬰幼兒，其他年齡層病患大多症狀輕微。由於臺灣疫苗接種率高，目前百日咳病患，大多是哥哥姊姊或父母等長輩帶菌回家，傳染給尚無免疫力的家中幼兒。
- **小兒麻痺症**：在醫學上稱為「脊髓灰白質炎」，是感染小兒麻痺病毒所引起，而人類是唯一的宿主，其感染來源是患者之糞便或口咽分泌物，感染後潛伏期約7-10天，病情輕的有發燒、頭痛、腸胃障礙、甚至頸背僵硬等症狀，重則造成肢體麻痺、終身殘障、甚至造成吞嚥或呼吸肌肉的麻痺而死亡。
- **b型嗜血桿菌**：是兒童上呼吸道常見的一種細菌，鼻咽部是主要的棲息處。能引起多種侵襲性疾病，其中以腦膜炎威脅性最大。病患絕大多數是5歲以下兒童，好發年齡主要在3個月至3歲之嬰幼兒，一半以上的病例為1歲以下的嬰兒。此外，有免疫功能低下的病患，包括：人類免疫不全症、先天性免疫球蛋白缺陷、骨髓移植、先天或後天性無脾臟病

症、接受化學治療的癌症等病患，容易因受到 b 型嗜血桿菌感染引發合併症，亦是高危險群。

◎認識疫苗

五合一疫苗是一種注射式的不活化疫苗，可以同時預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺以及 b 型嗜血桿菌等五種傳染病，此疫苗將舊型三合一疫苗中的全細胞性百日咳成分，改為非細胞性百日咳，可大幅減少接種後發生注射部位紅腫、疼痛或發燒等不良反應的機率，另外也用不活化小兒麻痺疫苗(IPV)取代口服小兒麻痺疫苗(OPV)，以避免發生機率極低的因疫苗引致小兒麻痺症(VAPP)的發生。

◎接種時程（99年3月起全面實施）

- 出生滿2個月
- 出生滿4個月
- 出生滿6個月
- 出生1歲6個月

◎接種禁忌

- 先前接種白喉、破傷風、百日咳、b 型嗜血桿菌、小兒麻痺相關疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
- 接種含百日咳疫苗後7天內曾發生腦病變，且無其他可解釋病因者。
- 出生未滿6週。

◎注意事項

- 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，宜於醫師判斷病情已經穩定後才注射疫苗。
- 先前接種含破傷風疫苗後6週內曾發生過GBS者。
- 曾接種含破傷風類毒素疫苗後，發生Arthus過敏反應者，與次劑含破傷風類毒素疫苗應間隔10年以上再接種。
- 曾發生下列狀況者需經專科醫師評估後再接種：
 1. 先前接種DTaP或DTP後48小時內曾發生不停嚴重哭鬧超過3小時、虛脫（collapsed）或類休克狀態（shock-like state）、發燒超過40.5°C（105°F），或接種後3天內曾發生痙攣（seizure）且無法以其他原因解釋者。

2. 需用藥物治療的心臟衰竭或發紺性心臟病者。

- 不適宜接種含百日咳疫苗之6歲以下幼兒，可改接種白喉破傷風混合疫苗（DT）及不活化小兒麻痺疫苗（IPV）。
- 滿7歲以上不適用。

◎接種後可能發生的反應及因應方式

- 接種後1-3天可能發生注射部位紅腫、酸痛，偶爾有哭鬧不安、疲倦、食慾不振或嘔吐等症狀，通常2-3天後會恢復。
- 不停啼哭或發高燒之症狀則較為少見；而嚴重不良反應如嚴重過敏、昏睡或痙攣則極為罕見。
- 如接種部位紅腫持續擴大、接種後持續高燒超過48小時或發生嚴重過敏反應及嚴重不適症狀，應儘速請醫師處理。

連結

[五合一疫苗Q&A](#)

最後更新日期 2013/1/9
